

Evaluation des états de choc hémorragique

QCM1

L'état de choc hémorragique est :

- A. Déséquilibre brutal entre apports et besoins en O₂ au niveau cellulaire
- B. Hypoperfusion tissulaire globale
- C. Hypoperfusion tissulaire périphérique
- D. Hypotension artérielle < à 90 mmHg
- E. Hyperlactatémie ≥ 2 mmol/l

Réponse : ABE

QCM2

Les Signes périphériques de choc sont :

- A. Tachycardie
- B. Bradycardie
- C. Pouls filant
- D. Froideurs des extrémités
- E. Marbrures

Réponse : ABCDE

QCM3

Au cours la phase sympatho-excitatrice d'un état de choc hémorragique :

- A. Baisse du retour veineux
- B. Vasoconstriction artérielle sélective
- C. Veino-constriction
- D. Tachycardie
- E. Inhibition du système sympathique

Réponse : ABCD

QCM4

Au cours la phase sympatho-inhibitrice d'un état de choc hémorragique :

- A. Apparaît pour des pertes sanguines de 30% de masse sanguine
- B. Baisse brutale des résistances vasculaires systémiques
- C. Bradycardie
- D. Anticipé et aggravé par l'induction anesthésique
- E. Est de durée 60 minutes.

Réponse : BCD

QCM5

Au cours d'un état de choc hémorragique, une hypoperfusion hépato-splanchnique responsable de :

- A. Libération de facteurs dépresseurs myocardiques
- B. Translocation bactérienne
- C. Atteinte de la macrocirculation responsable de SDMV
- D. Altérations profondes et durables des fonctions hépatiques.
- E. SIRS.

Réponse : ABCE

QCM6

Au cours d'un état de choc hémorragique, les objectifs tensionnels sont :

- A. PAS 80-90 mm Hg jusqu'au contrôle du saignement
- B. PAM 65 mm Hg chez un malade sans morbidité
- C. PAM 80 mm Hg si traumatisme crânien associé
- D. Coagulopathie apparaît pour une PAS < 70 mm Hg
- E. PAS 120 mm Hg au cours de la phase initiale

Réponse : ABCD

QCM7

Au cours d'un état de choc hémorragique, la triade létale est composé de :

- A. Hypothermie
- B. Thrombopénie
- C. Acidose
- D. Coagulopathie
- E. Hypocalcémie

Réponse : ACD

QCM8

Au cours d'un état de choc hémorragique, le diamant létal est composé de :

- A. Hypothermie
- B. Acidose
- C. Coagulopathie
- D. Hypocalcémie
- E. Thrombopénie

Réponse : ACDE

QCM9

Au cours d'un état de choc hémorragique, Le Seuil transfusionnel est:

- A. 7 g/dl Hb pour un malade sans morbidité

- B. 10 g/dl Hb chez un TC grave
- C. 8g/dl Hb chez une Insuffisance coronaire
- D. 9g/dl Hb chez malade en EDC septique
- E. 50.000 de plaquette chez un TC grave

Réponse : ABD

QCM10

La réanimation d'un état de choc hémorragique :

- A. Le PPSB est l'antidote pour les malades sous AOD.
- B. Acide Tranexamique (Exacyl®) à la dose de charge de 1 g / 10 mn.
- C. Facteur VIIa recombinant: Novoseven® de première intention au cours des HPP.
- D. L'objectif de calcium ionisé à maintenir > 0,9 mmol/L
- E. L'objectif de fibrinémie > 2 g/L chez le polytraumatisé.

Réponse : BD

QCM11

La réanimation transfusionnelle d'un état de choc hémorragique :

- A. La transfusion massive est défini par la transfusion d'une masse sanguines < 24 heures
- B. Dans le cas urgence vitale immédiate, le groupe sanguin à transfuser est le O positif
- C. Il faut probablement transfuser avec un ratio PFC:CGR compris entre 1:2 et 1:1
- D. Il est recommandé de différer la transfusion de plasma par rapport au CGR
- E. Le seuil inférieur tolérable de la numération plaquettaire est de 50 G/L

Réponse : ACE

QCM12

Au cours d'un état de choc hémorragique, Les objectifs des catécholamines :

- A. Maintenir pression de perfusion
- B. Limiter le remplissage vasculaire
- C. Prévenir l'hypotension induite par la sédation/analgésie
- D. Noradrénaline est le produit de choix
- E. Noradrénaline en cas de bradycardie

Réponse : ABCD

QCM13

L'acide Tranexamique dans la prise en charge du choc hémorragique :

- A. Il est recommandé d'administrer de l'acide Tranexamique dès que possible
- B. Permet la réduction le volume de l'HPP de 25 à 50%
- C. Son principal effet secondaire est thromboembolique
- D. Prescrit après l'ensemble des mesures médicales, transfusionnelles et chirurgicales

- E. Il est recommandé d'administrer de l'acide Tranexamique à la dose de 1 g en bolus IV en 10 min suivi de 1 g perfusé sur 8 h chez les patients traumatisés.

Réponse : ABE

QCM14

Administration concentré de Proconvertine (Facteur VIIa) Novoseven :

- A. Pour éviter une hystérectomie d'hémostase en obstétrique
- B. Après l'ensemble des mesures médicales, transfusionnelles et chirurgicales
- C. Fortement recommandé chez le polytraumatisé
- D. Dose initiale est de 60 à 90 µg/kg
- E. Renouvelable à une reprise à 90 – 120 µg/kg

Réponse : ABDE

QCM15

L'administration de concentré de Proconvertine (Facteur VIIa) Novoseven en obstétrique, après avoir corrigé:

- A. Acidose (pH < 7.20)
- B. Hypocalcémie (2.3 mmol/l)
- C. hypothermie (T < 35°)
- D. Fibrinémie (> 2g/l)
- E. plaquettes > 50 000
- F. Hb > 7g/l

Réponse : ABE

QCM16

A propos du choc hémorragique quelle est la réponse fausse ?

- A. Les signes cliniques apparaissent au-delà de 25% de perte de la masse sanguine
- B. La gazométrie sanguine retrouve fréquemment une acidose respiratoire
- C. L'oligurie est un bon reflet du retentissement rénal du choc
- D. La survenue d'une bradycardie est un signe de gravité
- E. L'obnubilation et l'agitation sont liées à la baisse du débit sanguin cérébral

Réponse : B

QCM17

L'hypo perfusion tissulaire lors de choc hémorragique peut être responsable :

- A. Oligurie
- B. Convulsions
- C. Hyperlactatémie
- D. Marbrures
- E. Trouble du transit

Réponse : ABCD

QCM18

En cas d'état de choc la valeur seuil pour une élévation des lactates est :

- A. 1 mmol/l
- B. 2 mmol/l
- C. 3 mmol/l
- D. 4 mmol/l
- E. 5 mmol/l

Réponse : B

QCM19

La cible minimale de la pression artérielle moyenne en cas de choc (hors traumatisme crânien grave et/ou médullaire)

- A. 50 mm hg
- B. 55 mm hg
- C. 60 mm hg
- D. 65 mm hg
- E. 75 mm hg

Réponse : D

QCM20

Quelle est l'amine utilisée de première intention quand le remplissage ne permet pas de restaurer une pression artérielle suffisante ?

- A. Adrénaline
- B. Noradrénaline
- C. Ephédrine
- D. Dopamine
- E. Dobutamine

Réponse : B

QCM21

Dans le cadre de la prise en charge thérapeutique du polytraumatisé, classer par ordre de priorité les gestes thérapeutiques suivants :

- A. Drainage d'un pneumothorax suffoquant.
- B. Oxygénation.
- C. Laparotomie pour plaie colique.
- D. Réparation d'une fracture ouverte du fémur.
- E. Évacuation d'un Hématome extra-dural.

Réponse: B – A – E – C – D

QCM22

Les Indications préopératoires potentielles d'une laparotomie écourtée chez un polytraumatisé

- A. Plaie pénétrante abdominale TA < 90 mmHg
- B. Polytraumatisé sévère avec traumatisme abdominal
- C. Fracture du bassin sévère avec traumatisme abdominal
- D. Catastrophe
- E. Champs de bataille

Réponse: ABCDE

QCM23

Les Indications peropératoires potentielles d'une laparotomie écourtée chez un polytraumatisé

- A. TA < 90 mmHg et Hypothermie < 34°C
- B. Coagulopathie majeur, TCA > 60s
- C. Acidose pH < 7.2
- D. Blessure vasculaire majeure intra abdominale
- E. Nécessité d'intervenir sur une lésion grave extra-abdominale

Réponse: ABCDE

QCM24

Au cours de l'état de choc hémorragique, les conséquences d'une hypothermie sont :

- A. Hyperventilation.
- B. Troubles du rythme cardiaque.
- C. Diminution du débit sanguin cérébral
- D. Troubles de la coagulation.
- E. Tendance à l'hyperkaliémie.

Réponse: BCDE